

Un genitore autistico nella vostra équipe ostetrica / materna

Per ostetriche, puericultrici e personale infermieristico materno e di comunità — sostenere un adulto autistico che è (o sta per diventare) genitore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un genitore si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Gravidanza, parto e primi tempi del genitorato sono incessanti, ad alto canale e imprevedibili — proprio le condizioni che un sistema monotropico trova più difficili — per cui i genitori autistici portano un **alto rischio di burnout** e spesso ignorano i propri bisogni. Gli ambienti materni e di comunità possono essere ostili sul piano sensoriale e pieni di sorprese. Una cura prevedibile, calma e letterale, con verifiche proattive, protegge sia il genitore sia il bambino.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
In sovraccarico sensoriale, ansioso o in shutdown in ambulatorio/travaglio	Un ambiente ad alto canale su un sistema monotropico — non „non ce la fa”
Salta gli appuntamenti, ignora il proprio dolore o i sintomi	Differenze di interocezione + iper-focus sul bambino
Routine rigide attorno a poppata e nanna	La prevedibilità riduce il carico — non è „controllo”
Diagnosticato solo dopo il proprio bambino	Una via comune all'identificazione adulta
Si fa silenzioso o non verbale sotto pressione	Shutdown — serve calma, non pressione a „partecipare”

Provate questo

- **Offrite l'AHAT dell'AASPIRE** e opzioni a **prima lo scritto**; permettete un partner o accompagnatore.
- **Rendete la cura perinatale prevedibile**: stessa clinica, stanza calma, piano scritto chiaro; spiegate ogni passaggio prima di farlo.
- **Chiedete proattivamente di dolore, esaurimento e alimentazione** — lo sottovaluteranno.
- **Riducete il carico sensoriale** in ambulatorio e in reparto (luce soffusa, meno bip, meno sorprese).
- **Cercate il burnout autistico e la malattia mentale perinatale** — le due si sovrappongono e necessitano entrambe di cure specifiche.

Da evitare

- Interpretare il sovraccarico o lo shutdown come „non si lega” al bambino, o come sola depressione.
- Visite a domicilio a sorpresa senza preavviso, o procedure imprevedibili.
- Dare per scontato che si autocercheranno aiuto quando faticano — spesso non lo fanno.

Quando chiedere altro supporto

State attenti al **burnout autistico** e alla malattia mentale perinatale; affrontate le condizioni co-occorrenti **ADHD, ansia, disturbi del sonno e gastrointestinali**. Segnalate il **supporto tra pari di genitori autistici** e l'aiuto pratico. Se in casa c'è un bambino neurodivergente, coordinatevi con i servizi pediatrici.

Se il genitore è una madre

Le madri autistiche sono spesso mal-diagnosticate (ansia/depressione perinatale) e mascherano intensamente, anche con i clinici. Chiedete delle differenze sociali/sensoriali lifelong, non solo dell'umore attuale.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 4), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3.4 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.